

TD Santé Publique communautaire — L2

TRAVAUX DIRIGÉS

Santé Publique, Surveillance Épidémiologique & Mobilisation Communautaire

Licence 2 — Infirmier(e) Diplômé(e) d'État / Sage-Femme

% Partie 1 — Surveillance des maladies cibles du PEV et maladies à potentiel épidémique

% Partie 2 — Monitoring de la couverture vaccinale : études de cas

% Partie 3 — Monitoring nutritionnel : exercices pratiques

% Partie 4 — Fléaux sociaux, diagnostic et mobilisation communautaire

Consignes générales : pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux ; pour chaque question à choix multiple, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) demandée(s). Tous les exercices sont à traiter.

PARTIE 1

SURVEILLANCE DES MALADIES CIBLES DU PEV ET MALADIES À POTENTIEL ÉPIDÉMIQUE

AFFIRMATIONS — VRAI OU FAUX

1. Dans la surveillance intégrée des maladies et réponse, il faut toujours acheminer les échantillons en bon état au laboratoire de l'Institut Pasteur dans un délai de 3 jours après collection.

Vrai & Faux &

2. Un cas confirmé de fièvre jaune au niveau communautaire est toute personne présentant un jaunissement soudain de la peau de plus de deux semaines, avec obligatoirement une forte chaleur corporelle.

Vrai & Faux &

3. La paralysie flasque aiguë est notifiée chez tout enfant présentant une faiblesse ou une diminution ou une perte du tonus musculaire de survenue de façon brutale.

Vrai & Faux &

4. En face d'un cas de paralysie flasque aiguë, il faut recueillir 3 échantillons de selles (8-10g) à un intervalle d'au moins 24-48 heures.

Vrai & Faux &

5. Il y a épidémie de fièvre jaune lorsqu'au moins un cas suspect est confirmé au laboratoire.

Vrai & Faux &

6. Toute personne quel que soit son âge présentant une maladie paralytique et chez qui l'on soupçonne une poliomyélite est un cas présumé de poliomyélite.

Vrai & Faux &

7. Un cas suspect de Tétanos néonatal est tout cas de décès néonatal survenu entre le 3ème et le 28ème jour de la vie et dont la cause est inconnue.

Vrai & Faux &

8. La classification des cas de tétanos néonatal est parfois clinique et ne dépend pas toujours d'une confirmation du laboratoire.

Vrai & Faux &

9. Un cas de syndrome respiratoire aigu sévère clinique est défini chez toute personne présentant des antécédents de fièvre ou une fièvre documentée.

Vrai & Faux &

10. Un cas suspect de rougeole est notifié chez un enfant présentant une fièvre, une éruption, une toux ou un coryza ou une conjonctivite.

Vrai & Faux &

11. Un cas suspect avec IgM positif est considéré comme un cas confirmé de rougeole.

Vrai & Faux &

12. Une suspicion d'épidémie de rougeole est survenue de 5 cas suspects ou plus, notifiés en un mois, pour une population de 100 000 habitants vivants dans un district sanitaire ou une aire de santé.

Vrai & Faux &

13. Épidémie de rougeole est dit confirmée si survenue de 3 cas confirmés ou plus, notifiés en un mois, pour une population de 100 000 habitants vivants dans un district sanitaire.

Vrai & Faux &

14. La cible du taux de PFA non poliomyélitique est d'au moins 2 cas pour 100 000 enfants de moins de 15 ans.

Vrai & Faux &

15. Proportion d'échantillons prélevés dans les 14 jours avant le début de la paralysie est 80%.

Vrai & Faux &

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE

16. Un cas de rougeole est dit confirmé si, parmi les propositions suivantes, choisir la bonne :

& A. C'est un cas suspect avec IgM positif : toutes les propositions sont bonnes

& B. C'est un cas suspect avec lien épidémiologique

& C. C'est un cas suspect confirmé cliniquement

17. La confirmation des cas de tétanos néonatal est :

& A. Clinique et ne dépend pas d'une confirmation du laboratoire

& B. Biologique et ne dépend pas d'une confirmation clinique

& C. Clinique et avec une confirmation de laboratoire

18. SIMR signifie :

& A. Surveillance intégrée de la maladie et riposte

& B. Système intégré de la maladie et la riposte

& C. Surveillance intégrée de la maladie et la riposte

& D. Système intégré de la morbidité et la riposte

& E. Surveillance intégrée de la morbidité et la riposte

19. Parmi les gestes suivants, indiquez ceux qu'il faut mener en cas de paralysie flasque aiguë : (plusieurs réponses possibles)

& A. Notifier immédiatement le cas aux autorités sanitaires du district

& B. Recueillir 2 échantillons de selles (8-10g) à un intervalle d'au moins 12-24 heures dans les 14 jours après l'apparition de la paralysie

& C. Recueillir 2 échantillons de selles (8-10g) à un intervalle d'au moins 24-48 heures dans les 14 jours après l'apparition de la paralysie

& D. Acheminer les échantillons en bon état au laboratoire de l'Institut Pasteur dans un délai de 3 jours après collection

& E. Acheminer les échantillons en bon état au laboratoire de l'Institut Pasteur dans un délai de 10 jours après collection

& F. Notifier immédiatement le cas aux autorités sanitaires de l'Institut d'Hygiène

20. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles qui sont sous surveillance en Côte d'Ivoire : (sélectionnez 3 options — 3 points)

& A. Le choléra

- & B. Le paludisme
- & C. La fièvre hémorragique virale
- & D. La dracunculose
- & E. Les infections respiratoires aiguës
- & F. Les infections urinaires

21. En cas de paralysie flasque aiguë, un prélèvement des selles se fait : (sélectionnez 2 options)

- & A. Entre J10 et J14
- & B. Entre J14 et J60
- & C. Entre J61 et 06 mois
- & D. Après 06 mois

22. Parmi les signes suivants, indiquez celui qui est cité dans la définition de cas probable de fièvre jaune au niveau d'une structure sanitaire :

- & A. Une fièvre d'apparition brusque, ictère apparaissant dans les 14 jours après le début des symptômes
- & B. Présence de IgM dans le sang avec histopathologie du foie positive
- & C. Présence d'anticorps neutralisants spécifiques chez un sujet non vacciné dans les 30 jours

PARTIE 2

MONITORAGE DE LA COUVERTURE VACCINALE — ÉTUDES DE CAS

Étude de cas 1

Infirmier(ère), sage-femme ou maïeuticien en fin de formation, vous avez été affecté(e) au centre de santé rural d'Adikokoi dans le district sanitaire d'Akoupé, le 1er juillet 2018.

À la fin de l'année 2017, la population cible supplémentaire des femmes en âge de reproduction de l'aire sanitaire est estimée à 1 950. La population totale de cette même aire de santé projetée au 1er janvier 2019 est estimée à 10 043 habitants.

L'analyse des rapports d'activités de l'année 2019 et d'une étude du milieu ont permis de noter les informations suivantes :

255 naissances vivantes ;

85 décès d'enfants dont l'âge est compris entre 0 et 11 mois ;

03 cas de rougeole chez les enfants de 0 à 23 mois ;

les pathologies prédominantes de la localité sont le paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires aiguës ;

345 décès d'adultes dont 85 dus aux IRA, 105 au paludisme, 75 à la diarrhée aiguë et 80 à d'autres causes ;

un taux de couverture vaccinale de 45% pour le RR atteint au premier semestre.

Un monitoring réalisé sur l'activité de vaccination au 1er semestre de l'année 2019 chez les enfants de 0-23 mois a permis de faire les constats suivants : un important goulot d'étranglement entre la disponibilité des ressources et l'accessibilité géographique.

1. La population totale de l'aire sanitaire d'Adikokoi au 31/12/2017 est : (cocher la bonne réponse)

- & A. 30.240 habitants
- & B. 7.560 habitants
- & C. 9.750 habitants
- & D. 7.800 habitants

2. Le taux d'accroissement annuel de la population est : (cocher la bonne réponse)

- & A. 3,5%

& B. 3%

& C. 5,6%

& D. 0,05%

& E. 0,03%

3. La population totale d'Adikokoi à la fin de l'année 2019 est : (cocher la bonne réponse)

& A. 10.045 habitants

& B. 13.0560 habitants

& C. 10.345 habitants

& D. 17.800 habitants

4. Pour l'année 2019, le taux de mortalité infantile est : (cocher la bonne réponse)

& A. 333,33 p.1000

& B. 0,333 p.1000

& C. 33,4 p.10000

& D. 33,33 p.100

& E. 444 p.1000

5. Pour l'année 2019, le taux de mortalité spécifique des IRA au sein de la population adulte est estimé à : (cocher la bonne réponse)

& A. 8%

& B. 0,833 p.1000

& C. 9%

& D. 8,33 p.1000

& E. 1,8%

6. La population cible qui a servi à réaliser ce monitoring est :

& A. 353 enfants

& B. 414 enfants

& C. 207 enfants

& D. 345 enfants

& E. 307 enfants

7. Parmi les causes probables ci-dessous, cochez deux qui pourraient expliquer l'important goulot d'étranglement situé entre la DR et l'AG :

& A. Attente trop longue pour les patients

& B. Considérations socioculturelles

& C. Inexistence ou non-fonctionnement des cases de santé

& D. Rupture des ressources (vaccins, etc.)

& E. Inaccessibilité géographique de la population

8. Le nombre d'enfants de 0 à 23 mois qui reste à vacciner pour le second semestre de l'année 2019 avec le RR, si l'on veut protéger tous les enfants contre la rougeole et la rubéole, est : (cocher la bonne réponse)

& A. 227 enfants

& B. 272 enfants

& C. 389 enfants

& D. 178 enfants

& E. 427 enfants

Étude de cas 2

Après votre formation, vous êtes affecté(e) dans le centre de santé rural d'Akakro, dans le district de Bongouanou, qui couvre une population de 10 400 habitants en 2019. Pour avoir une idée claire de la performance de votre prédécesseur, vous consultez les documents de monitoring des années écoulées et vous tombez sur celui réalisé en juin 2019 sur l'activité de vaccination, qui donne le diagramme suivant :

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Diagramme de couverture de l'activité de vaccination réalisée au centre de santé d'Akakro en 2019 (graphique du document source non exploitable — échelle reproduite à l'identique)

1. Le monitoring permet de :

- & A. Suivre l'avancement d'un programme
- & B. Déterminer quel groupe a bénéficié d'un programme
- & C. Identifier les problèmes au cours de la réalisation d'un programme
- & D. S'assurer que les résultats attendus se déroulent selon le plan établi

2. En Côte d'Ivoire, le rythme des activités de monitoring est :

- & A. Annuel
- & B. Semestriel
- & C. Trimestriel
- & D. Bimensuel

3. Le monitoring réalisé en juin 2019 dans ce centre de santé (CSR d'Akakro) a permis d'évaluer les couvertures de :

- & A. Juin 2019 à novembre 2019
- & B. Juillet 2019 à décembre 2019
- & C. Décembre 2018 à mai 2019
- & D. Juin 2018 à novembre 2018

4. Pour mesurer l'accessibilité géographique de l'activité de vaccination dans ce centre, l'infirmier a utilisé comme indicateur :

- & A. Le pourcentage de la population cible habitant dans un rayon de moins de 05 km autour du CSR d'Akakro et des postes de stratégies avancées
- & B. Le pourcentage de la population cible habitant dans un rayon de 05 km autour du CSR d'Akakro et des postes de stratégies avancées
- & C. Le pourcentage de la population cible habitant dans un rayon de 10 km autour du CSR d'Akakro et des postes de stratégies avancées
- & D. Le pourcentage de la population cible habitant dans un rayon de 15 km autour du CSR d'Akakro et des postes de stratégies avancées

5. Un des items suivants n'est pas un déterminant de couverture. Lequel ?

- & A. Disponibilité des ressources (DR)
- & B. Accessibilité géométrique (AG)
- & C. L'utilisation des services (US)
- & D. Couverture effective (CE)

6. La population cible (0-23 mois) qui a permis de réaliser ce monitoring est de :

- & A. 520 enfants
- & B. 416 enfants
- & C. 355 enfants

& D. 208 enfants

7. Sur ce diagramme de couverture, le principal goulot se situe entre :

& A. CA et CE

& B. PC et AG

& C. US et CA

& D. AG et CE

& E. DR et AG

8. La cause du principal goulot d'étranglement dans cette liste est :

& A. Le mauvais accueil

& B. La négligence des parents

& C. La non-maîtrise des techniques de soins

& D. La rupture fréquente des vaccins

& E. La non-insistance sur les rendez-vous

PARTIE 3

MONITORAGE NUTRITIONNEL — EXERCICES PRATIQUES (VITAMINE A / PESÉE)

Les données issues de l'activité de pesée du centre de santé rural de Kouassiblèkro, district sanitaire de Bouaké Nord-Ouest, font ressortir de nombreux cas de malnutrition. Voulant comprendre les causes de cette prévalence élevée, le Directeur Départemental de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle vous invite, pendant votre stage communautaire, à faire partie de l'équipe chargée de l'organisation du monitoring sur l'activité de pesée. La période du 01/06/2023 au 30/11/2023 a été choisie pour ce monitoring. Les informations sur la pesée de cette période dudit centre sont les suivantes :

population totale actualisée de la localité de Kouassiblèkro pour l'année 2023 : 5 000 habitants ;

150 enfants ayant une couverture adéquate en pesée ont le tracé de la courbe de croissance qui se situe dans le chemin de la santé ;

250 enfants ont été pesés au moins quatre fois à intervalle d'un mois entre les pesées et ont reçu une dose correcte de vitamine A avec tracé de la courbe de croissance ;

320 enfants ont été pesés au moins une fois pendant la période du monitoring et ont reçu la vitamine A ;

400 mères d'enfants de 0 à 5 ans vivaient dans un rayon de moins de 5 km autour du centre pendant la période du monitoring ;

pendant la période du monitoring, la vitamine A a connu 42 jours de rupture.

Questions — à partir des données sur la pesée du centre de santé rural de Kouassiblèkro et en calculant les indicateurs mentionnés, mesurez chaque déterminant de la couverture pour l'intervention ci-dessus mentionnée.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE

1. Quelle est la population cible annuelle des enfants de 0 à 5 ans de la localité de Kouassiblèkro pour l'année 2023 ?

& A. 1000 enfants de 0 à 5 ans

& B. 1500 femmes enceintes

& C. 500 femmes enceintes

& D. 2020 femmes enceintes

2. Quelle est la population cible du monitoring des enfants de 0 à 5 ans de la localité de Kouassiblèkro pour l'année 2023 ?

& A. 425 femmes enceintes

& B. 400 femmes enceintes

& C. 250 femmes enceintes

& D. 500 femmes enceintes

3. Quelle est la disponibilité en vitamine A du centre de santé rural de Kouassiblèkro pendant la période du monitoring ?

& A. 80%

& B. 77%

& C. 90%

& D. 85%

4. Quelle est l'accessibilité des enfants de 0 à 5 ans pendant la période du monitoring ?

& A. 90%

& B. 77%

& C. 80%

& D. 85%

5. Quelle est l'utilisation du centre en vitamine A par les enfants de 0 à 5 ans pendant la période du monitoring ?

& A. 83%

& B. 84%

& C. 86%

& D. 64%

6. Quelle est la couverture adéquate en pesée du centre de santé rural de Kouassiblèkro ?

& A. 78%

& B. 75%

& C. 50%

& D. 70%

7. Quelle est la couverture effective en pesée du centre de santé rural de Kouassiblèkro ?

& A. 35%

& B. 30%

& C. 25%

& D. 32%

8. Combien de goulots d'étranglement ont été identifiés par le monitoring ?

& A. 05 goulots d'étranglement

& B. 01 goulot d'étranglement

& C. 03 goulots d'étranglement

& D. 04 goulots d'étranglement

9. Quels sont les goulots d'étranglement ?

& A. Il y a un goulot d'étranglement entre la PC et la DR

& B. Il y a un goulot d'étranglement entre l'AG et l'US

& C. Il y a un goulot d'étranglement entre l'US et la CA

& D. Il y a un goulot d'étranglement entre la CA et la CE

& E. Toutes les réponses sont justes

10. Quelle est l'une des causes des goulots d'étranglement identifiés ?

- & A. Insuffisance de la vitamine A pour satisfaire toute la population cible du monitoring
- & B. Présence, au sein des populations, de préjugés liés à la prise de la vitamine A
- & C. Mauvais accueil des mères des enfants de 0 à 5 ans par le personnel de santé
- & D. Méconnaissance de la posologie de la vitamine A par le personnel de santé
- & E. Toutes les réponses sont justes

11. Quelle est l'une des stratégies face au(x) goulot(s) d'étranglement identifié(s) ?

- & A. Approvisionnement du centre en vitamine A
- & B. Lutter contre les préjugés par une éducation ciblée, permanente et respectueuse des coutumes
- & C. Réserver un accueil humaniste aux mères des enfants de 0 à 5 ans qui viennent à la pesée
- & D. Formation du personnel de santé sur la posologie de la vitamine A
- & E. Toutes les réponses sont justes

QUESTIONS À CHOIX DOUBLE — VRAI OU FAUX

12. Le monitoring des activités peut être comparé au suivi de ces activités.

Vrai & Faux &

13. Le monitoring est une activité qui mesure les résultats.

Vrai & Faux &

14. L'évaluation est une activité qui mesure les stratégies.

Vrai & Faux &

15. L'évaluation des couvertures dans le cadre du monitoring permet d'ajuster les stratégies.

Vrai & Faux &

16. Le monitoring des activités permet de réadapter les stratégies identifiées pour corriger les goulots d'étranglement.

Vrai & Faux &

17. Les déterminants de couverture sont aussi être appelés critères dans le cadre du monitoring.

Vrai & Faux &

18. Dans le monitoring d'une activité, le respect de l'alignement des déterminants de couverture de la population cible à la couverture effective est obligatoire.

Vrai & Faux &

19. En Côte d'Ivoire, le monitoring des activités se fait deux fois dans l'année.

Vrai & Faux &

20. La période du monitoring exprimée en jour est de 182 et 183 jours.

Vrai & Faux &

21. Dans le cadre du monitoring d'une activité, deux méthodes sont utilisées pour le calcul de la disponibilité des ressources.

Vrai & Faux &

22. Le calcul de l'accessibilité géographique dans le cadre du monitoring tient compte des populations résidant dans un rayon de 5 km du centre et celles des villages ayant bénéficié d'au moins une stratégie avancée.

Vrai & Faux &

23. La couverture adéquate est le dernier dans la hiérarchisation des déterminants de couverture.

Vrai & Faux &

PARTIE 4

FLÉAUX SOCIAUX, DIAGNOSTIC ET MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

I. Fléaux sociaux

1. L'effet aigu de l'alcoolisme se manifeste par l'accélération du rythme cardiaque.

Vrai & Faux &

2. Un stupéfiant est une substance psychotrope dont l'usage répété conduit à une dépendance.

Vrai & Faux &

3. La pharmacodépendance est un état résultant de l'absorption périodique ou continue d'une drogue naturelle.

Vrai & Faux &

4. La dépendance résulte de l'absorption continue et répétée de drogue ou leurs dérivés.

Vrai & Faux &

5. L'accoutumance est un phénomène par lequel l'organisme devient peu à peu sensible à un produit régulièrement absorbé et qui oblige souvent le toxicomane à augmenter les doses.

Vrai & Faux &

6. L'accoutumance est un phénomène par lequel l'organisme devient peu à peu insensible à un produit régulièrement absorbé et qui oblige souvent le toxicomane à augmenter les doses.

Vrai & Faux &

7. L'alcool est sans doute la drogue la plus disponible et accessible dans le monde entier.

Vrai & Faux &

8. Tolérance est la propriété que possède un organisme de supporter des doses d'une substance donnée, sans manifester des signes d'intoxication.

Vrai & Faux &

9. La dépendance est la propriété que possède l'organisme de supporter des doses d'une substance sans manifester des signes d'intoxication.

Vrai & Faux &

10. Interdire la vente de l'alcool devant et à l'intérieur des écoles est une mesure préventive de l'alcoolisme.

Vrai & Faux &

11. Le ralentissement des réflexes jusqu'au coma est un effet aigu de la drogue.

Vrai & Faux &

12. Toxicomanie est état d'intoxication périodique ou chronique nuisible à l'individu et à la société engendré par la consommation d'une drogue naturelle ou synthétique.

Vrai & Faux &

13. Parmi les propositions suivantes, cochez celle qui définit l'accoutumance :

& A. Un phénomène par lequel l'organisme devient peu à peu insensible à un produit régulièrement absorbé

& B. Un état résultant de l'absorption périodique ou continue de certaines substances chimiques

& C. La propriété que possède l'organisme de supporter des doses d'une substance

II. Diagnostic communautaire

1. Le diagnostic communautaire permet de renforcer les activités effectuées en santé communautaire.

Vrai & Faux &

2. La gravité d'un problème prioritaire de santé peut se déterminer à partir des séquelles de cette maladie.

Vrai & Faux &

3. La vulnérabilité d'un problème prioritaire de santé se détermine par l'existence de mesures de

contrôle efficaces du problème.

Vrai & Faux &

4. L'approche psychosociologique des besoins en vue du diagnostic communautaire permet de fournir des données quantitatives.

Vrai & Faux &

5. L'un des buts du diagnostic communautaire est d'identifier les principaux problèmes de santé d'une communauté et ses ressources pour envisager les solutions et des actions ciblées sur les problèmes repérés.

Vrai & Faux &

6. Le diagnostic communautaire permet de baser les efforts sur les besoins réels de la population.

Vrai & Faux &

7. L'approche basée sur la notion épidémiologique du besoin en vue du diagnostic communautaire permet de fournir des données quantitatives.

Vrai & Faux &

8. Les étapes à suivre pour la conduite d'un diagnostic communautaire sont au nombre de huit.

Vrai & Faux &

9. Le choix des problèmes prioritaires en santé publique obéit à des critères dont les principaux sont :

& A. Les femmes enceintes

& B. La population cible touchée par le problème

& C. L'ampleur du problème (le nombre de cas)

& D. La gravité du problème (le nombre de décès ou de séquelles)

& E. La vulnérabilité du problème

& F. La perception du problème par la population

& G. Le coût des interventions

10. Voici une liste de populations cibles et de pondérations en vue de la sélection d'un problème prioritaire. Identifiez les bonnes combinaisons entre les populations-cibles et les pondérations :

Populations cibles : 1. Vieillards — 2. Femmes enceintes — 3. Enfants — 4. Adultes

Pondérations : a. 02 points — b. 05 points

& A. (b : 1,3)

& B. (a : 2,3)

& C. (a : 2,4)

& D. (b : 1,4)

11. Voici une liste de nombres de cas et de pondérations en vue de la sélection d'un problème prioritaire. Identifiez les bonnes combinaisons entre les catégories et les pondérations :

Pondérations : a. 05 points — b. 02 points — c. 04 points

Catégories : 1. Entre 10 à 19 cas — 2. 20 cas et plus — 3. < à 10 cas

& A. (b,1)

& B. (1,2)

& C. (a,3)

& D. (c,2)

& E. (c,1)

& F. (b,3)

III. Mobilisation sociale et communautaire

1. L'un des rôles joués par l'agent de santé pendant la mobilisation communautaire est le rôle de catalyseur.

Vrai & Faux &

2. Les mobilisateurs sociaux sont des non-résidents et choisis par la communauté.

Vrai & Faux &

3. Les mobilisateurs sociaux doivent être bénévoles et exercer en plein temps.

Vrai & Faux &

4. L'insuffisance de mobilisateurs est un obstacle à la mobilisation sociale.

Vrai & Faux &

5. La société toute entière fait partie des acteurs de la mobilisation communautaire.

Vrai & Faux &

6. Les populations bénéficiaires de la mobilisation communautaire sont la famille et les ONG.

Vrai & Faux &

7. Un agent de santé communautaire peut utiliser la communication de masse pour mener son activité de sensibilisation dans le village.

Vrai & Faux &

8. Dans le cadre de la mobilisation communautaire, la planification des activités consiste à :

& A. Identifier les objectifs généraux ainsi que les objectifs spécifiques

& B. Exécuter les activités selon le plan établi

& C. Suivre les activités pendant leur exécution

9. Cochez les deux objectifs de la mobilisation sociale : (sélectionnez 2 options)

& A. La participation passive de la communauté

& B. Faciliter le changement de comportement

& C. Accroître les connaissances

& D. Avoir un système financier fonctionnel

& E. Être prêt à faire du bénévolat

& F. Avoir un soutien logistique

10. Un des objectifs de la mobilisation sociale est :

& A. La participation passive de la communauté

& B. Décroître les connaissances

& C. Faciliter le changement de comportement

11. La mobilisation sociale a pour but de :

& A. Inciter à l'action le plus grand nombre de personnes afin d'atteindre un objectif social commun

& B. Promouvoir la santé communautaire

& C. Changer une situation sociale en un sens défavorable à la société selon ses valeurs et motivations